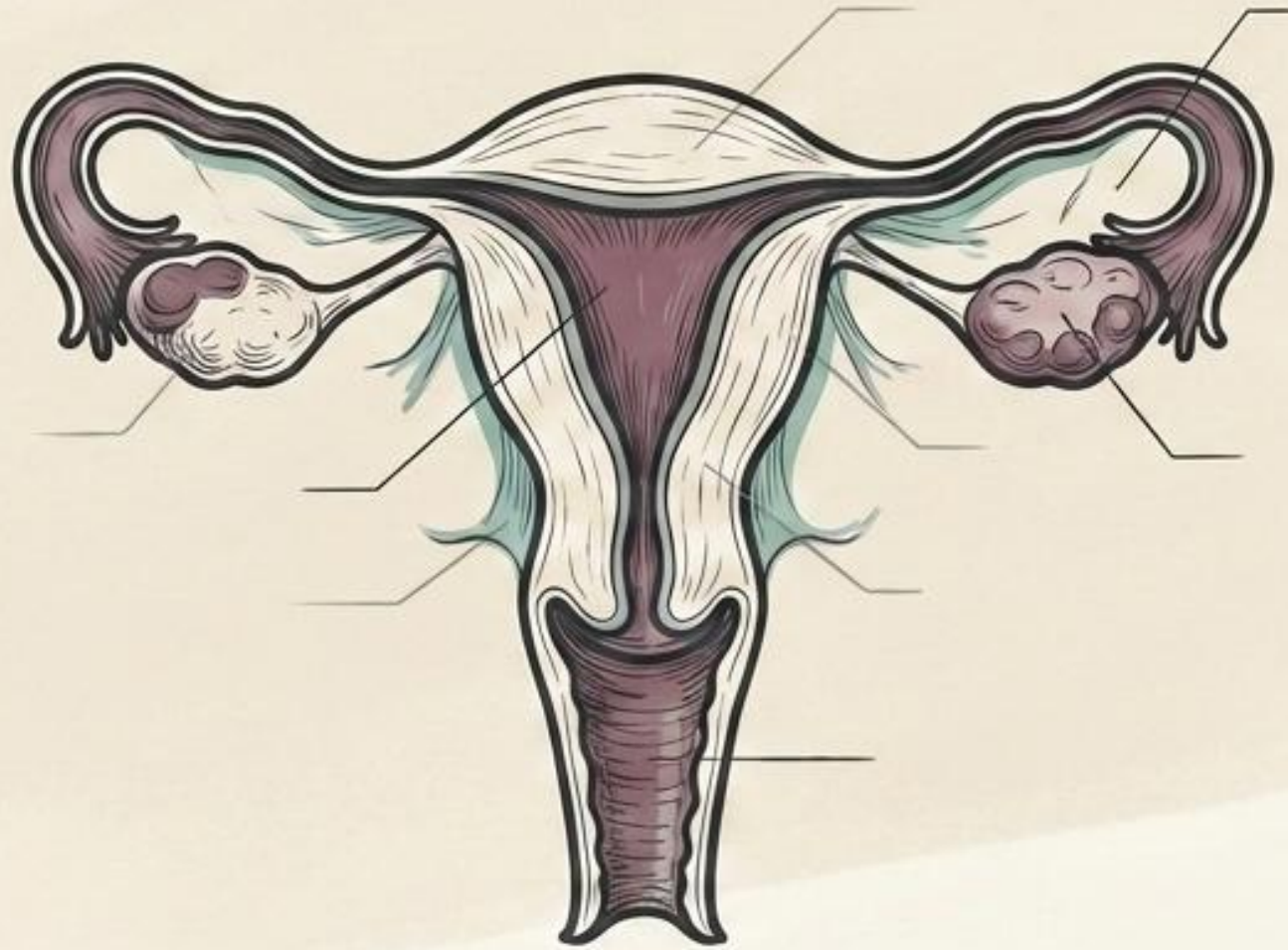


Chapter 19: Appareil Génital Féminin

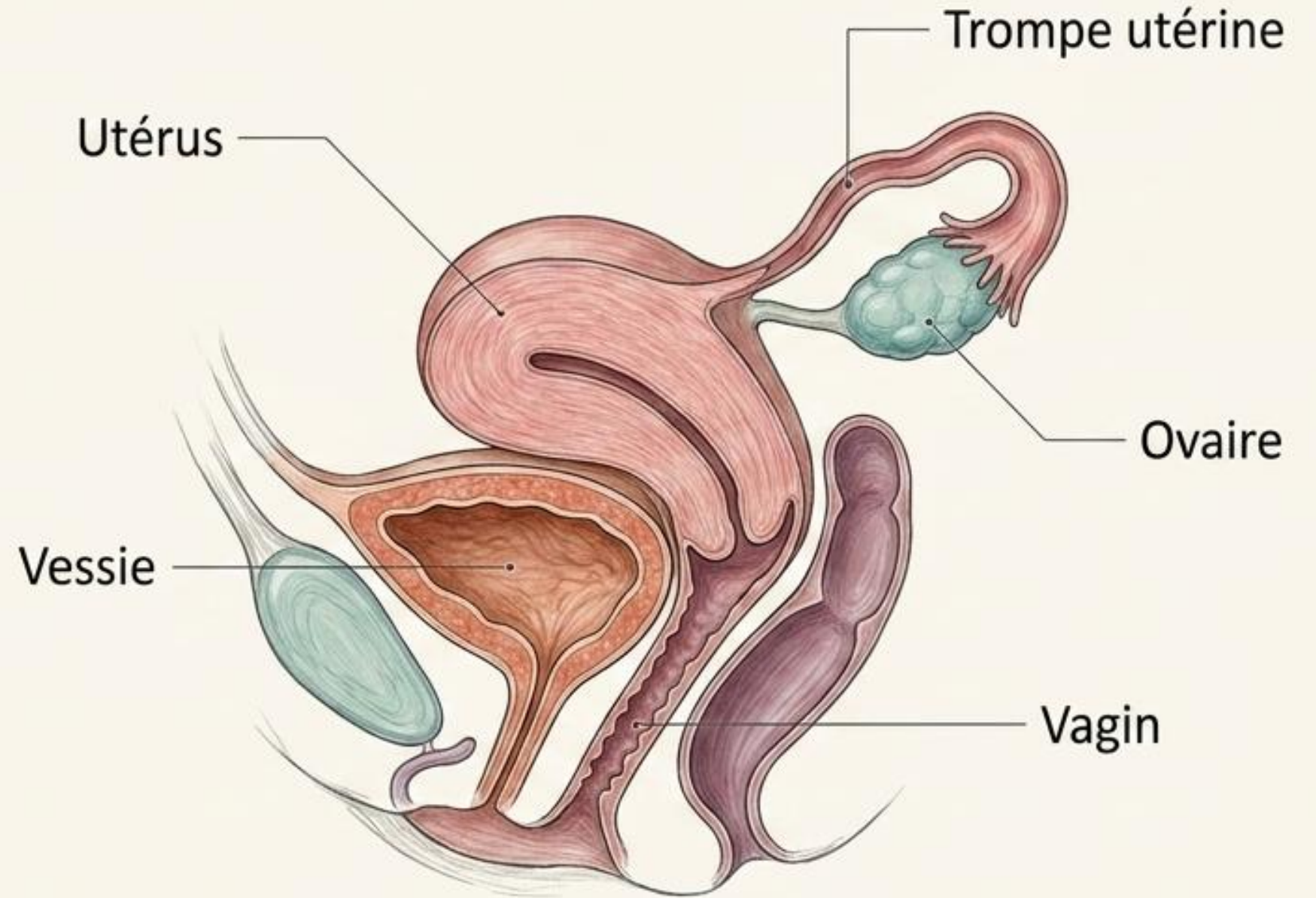
Anatomie fonctionnelle, physiologie et approche ROP



La Loge Viscérale

- **Antérieur** : La Vessie.
- **Central** : L'Utérus (mobile, au-dessus de la vessie).
- **Postérieur** : L'Ampoule rectale.

Le cul-de-sac recto-utérin de Douglas est le point le plus déclive de la cavité abdominale.

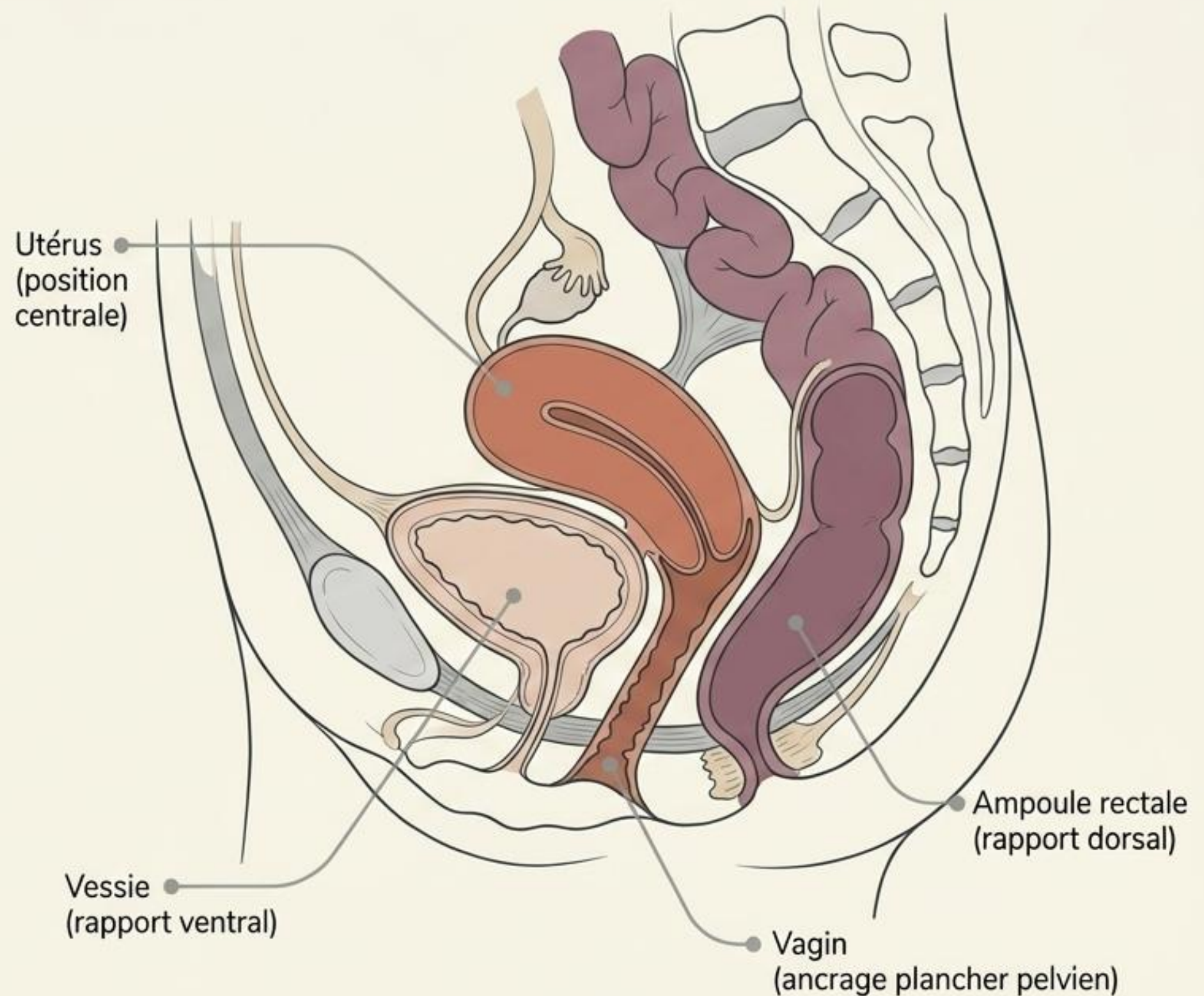


La Loge Viscérale Pelvienne

L'utérus occupe une position centrale, hautement vulnérable, au-dessus de la vessie et en avant du rectum.

Enjeu Clinique ROP

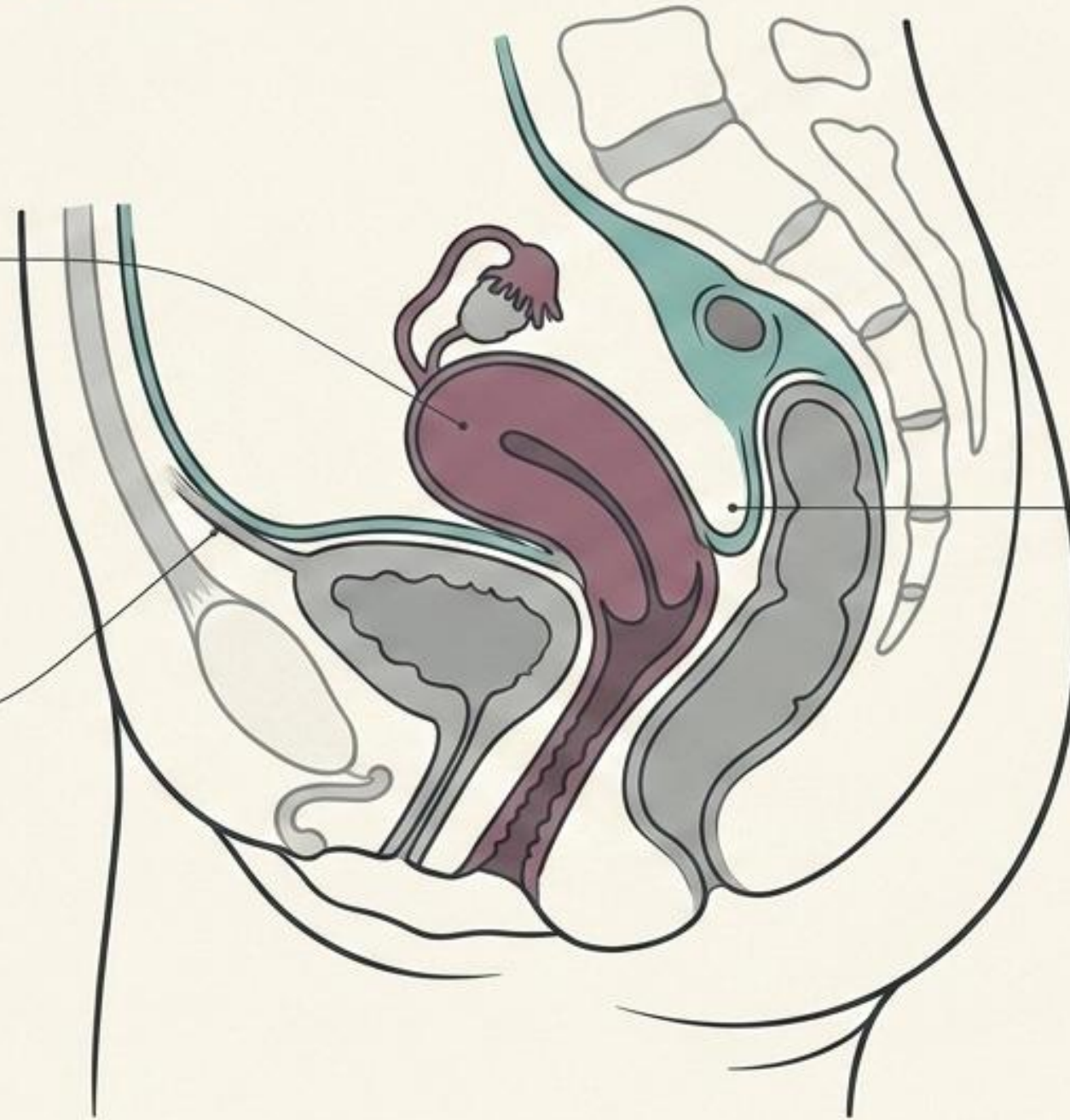
- Les femmes sont particulièrement exposées aux dysfonctions uro-génitales tout au long de leur vie.
- Facteurs aggravants : grossesses, épisiotomies, ventouses, sédentarité, traumatismes.
- Symptômes d'alerte : derrière une lombalgie, sciatalgie ou dyspareunie peut se cacher une malposition utérine ou une dysfonction ovarienne.



Loge viscérale et topographie pelvienne

Utérus : position centrale dans la loge viscérale, au-dessus de la vessie et en avant de l'ampoule rectale.

Anneau inguinal profond et superficiel : passage du ligament rond.



Cul-de-sac recto-utérin de Douglas : point le plus déclive de la cavité abdominale.

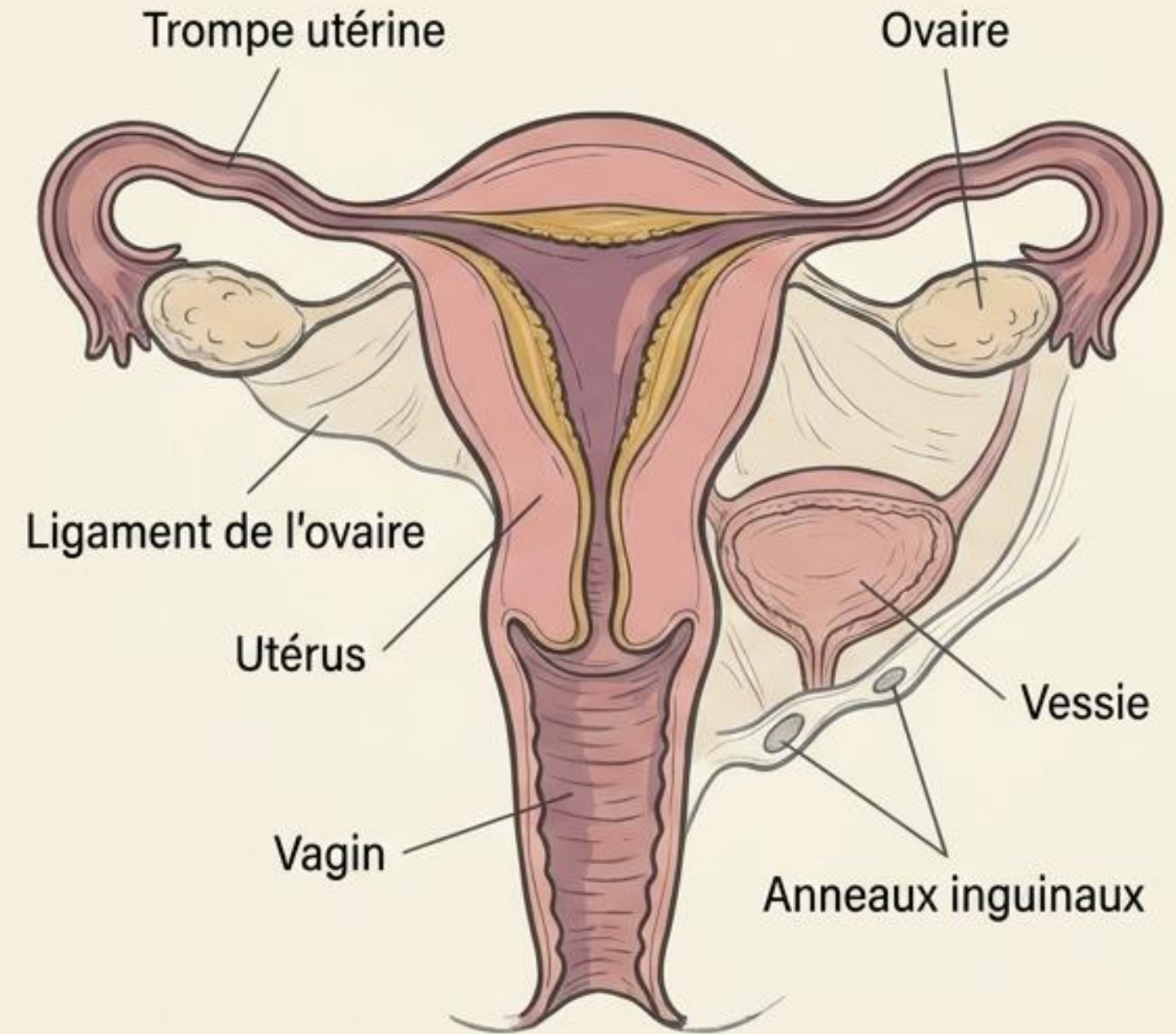
L'utérus est soumis aux pressions constantes des organes adjacents. La réplétion de la vessie verticalise et repousse le corps utérin vers l'arrière.

Architecture Spatiale de l'Appareil Reproducteur

Un Système Sous Influence Constante

De la puberté à la ménopause, l'utérus et ses annexes sont harcelés par de multiples facteurs : grossesses, traumatismes, sédentarité, et déséquilibres hormonaux.

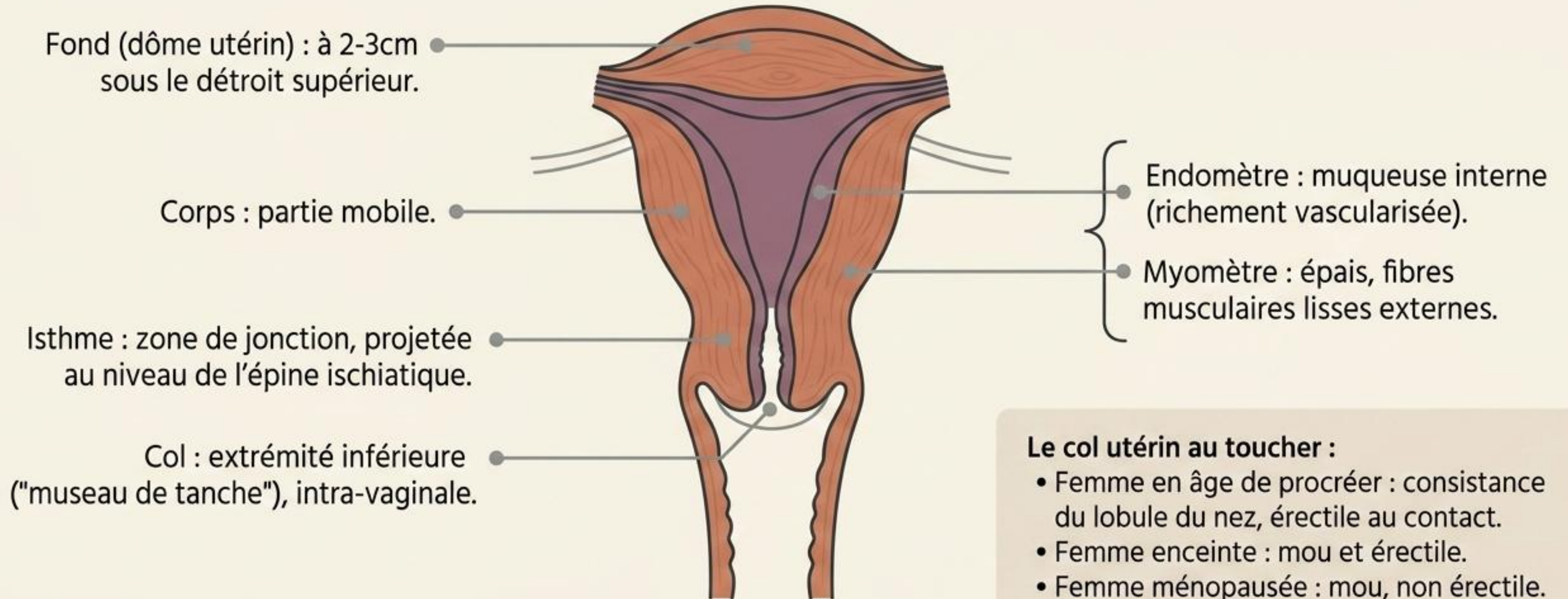
- **Utérus** : Organe central de gestation, forme de cône. Poids : 70 à 80gr (involution post-ménopause). Dimensions (nullipare) : 6-7cm de long, 4cm de large.
- **Vagin** : Incliné à 60-70° par rapport à l'horizontal. Puissant moyen de soutènement des organes urogénitaux (la base de la vessie repose sur lui).



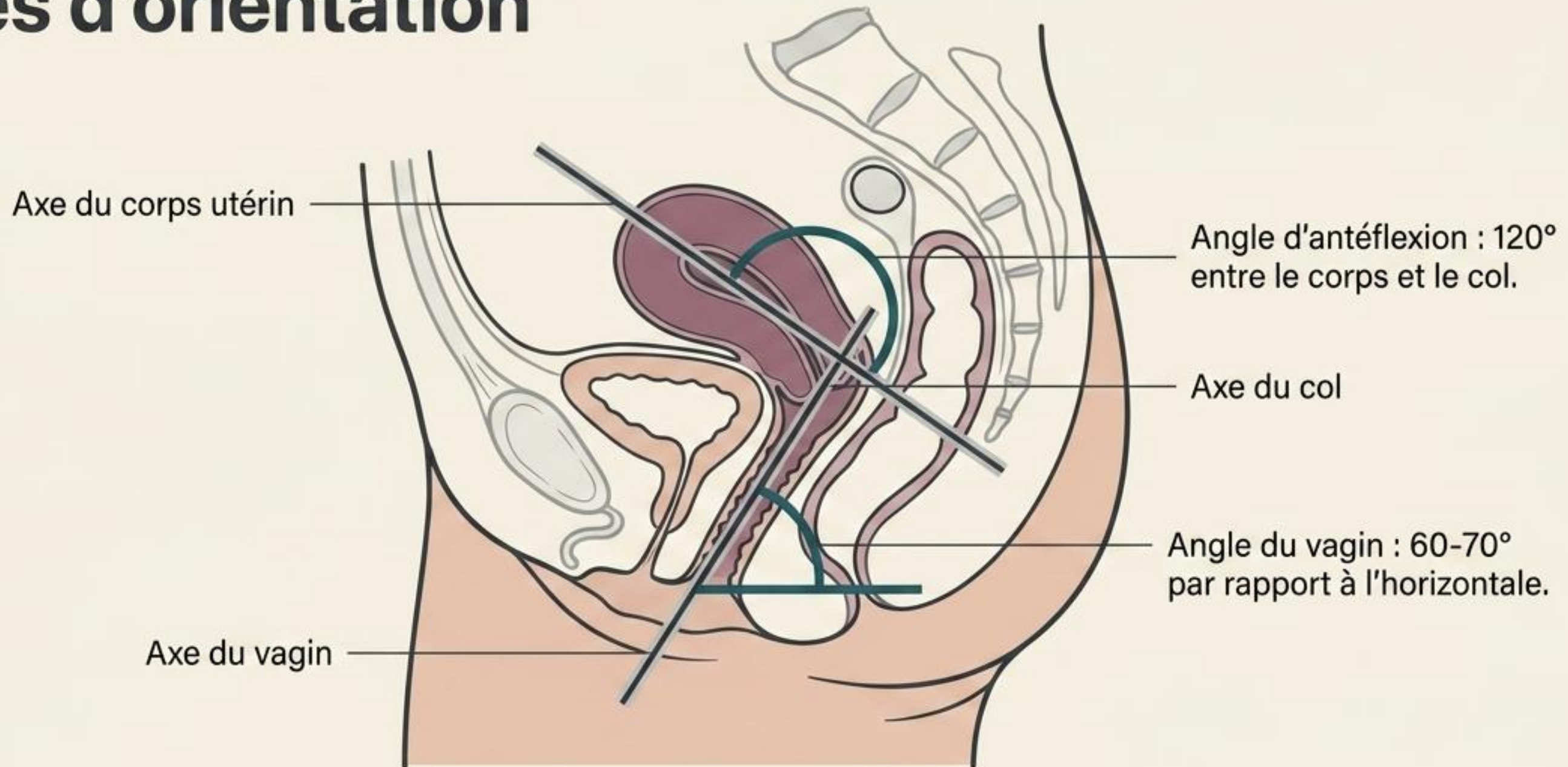
Morphologie de l'Utérus

Organe de la gestation, structuré en cône.

Poids moyen : 70-80g (évolutif jusqu'à la ménopause).



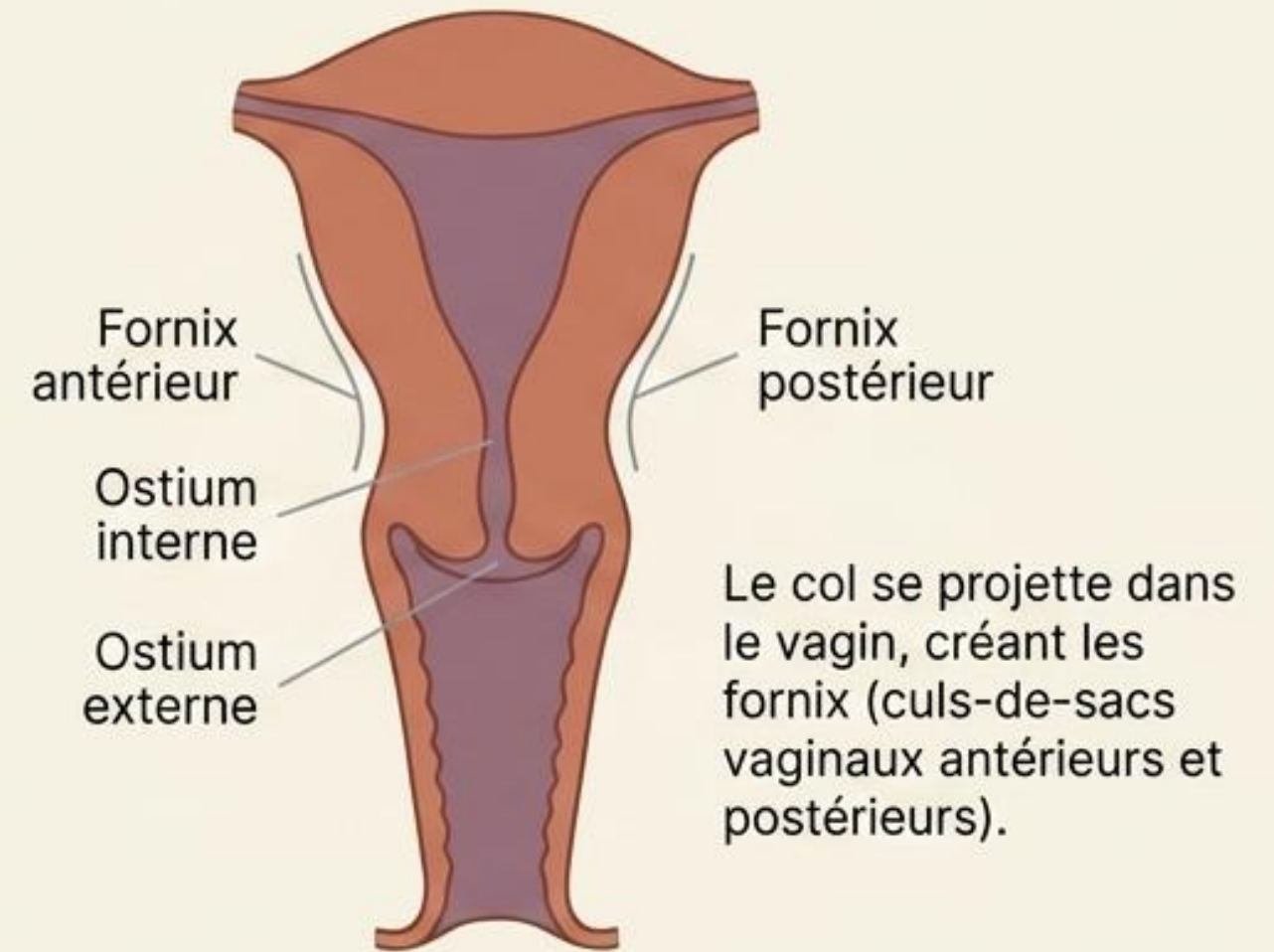
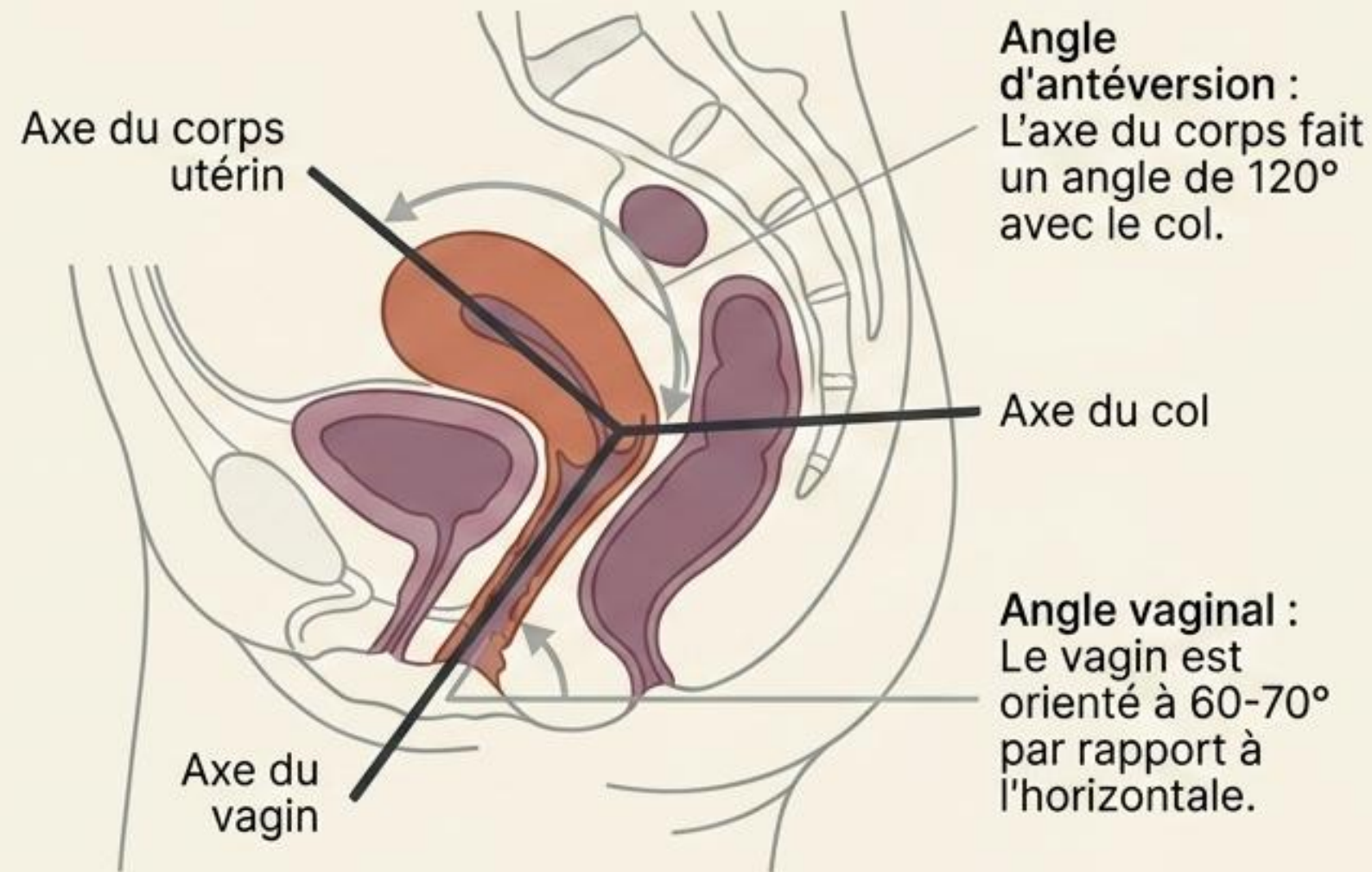
Statique génito-pelvienne et axes d'orientation



Physiologiquement, l'utérus est antéversé et antéfléchi. Les déviations (rétroversion, rétroflexion) altèrent ces angles et sont tributaires des tensions ligamentaires.

La Statique Utérine : Les Axes

Dans un plan sagittal, chez la femme debout, l'utérus est physiologiquement antéversé et antéfléchi.



La situation de l'utérus dépend entièrement de la tension de ses moyens de fixation.
Les culs-de-sacs s'effacent selon l'axe de déviation du col.

La Statique Pelvienne : La "Croix de Richard"

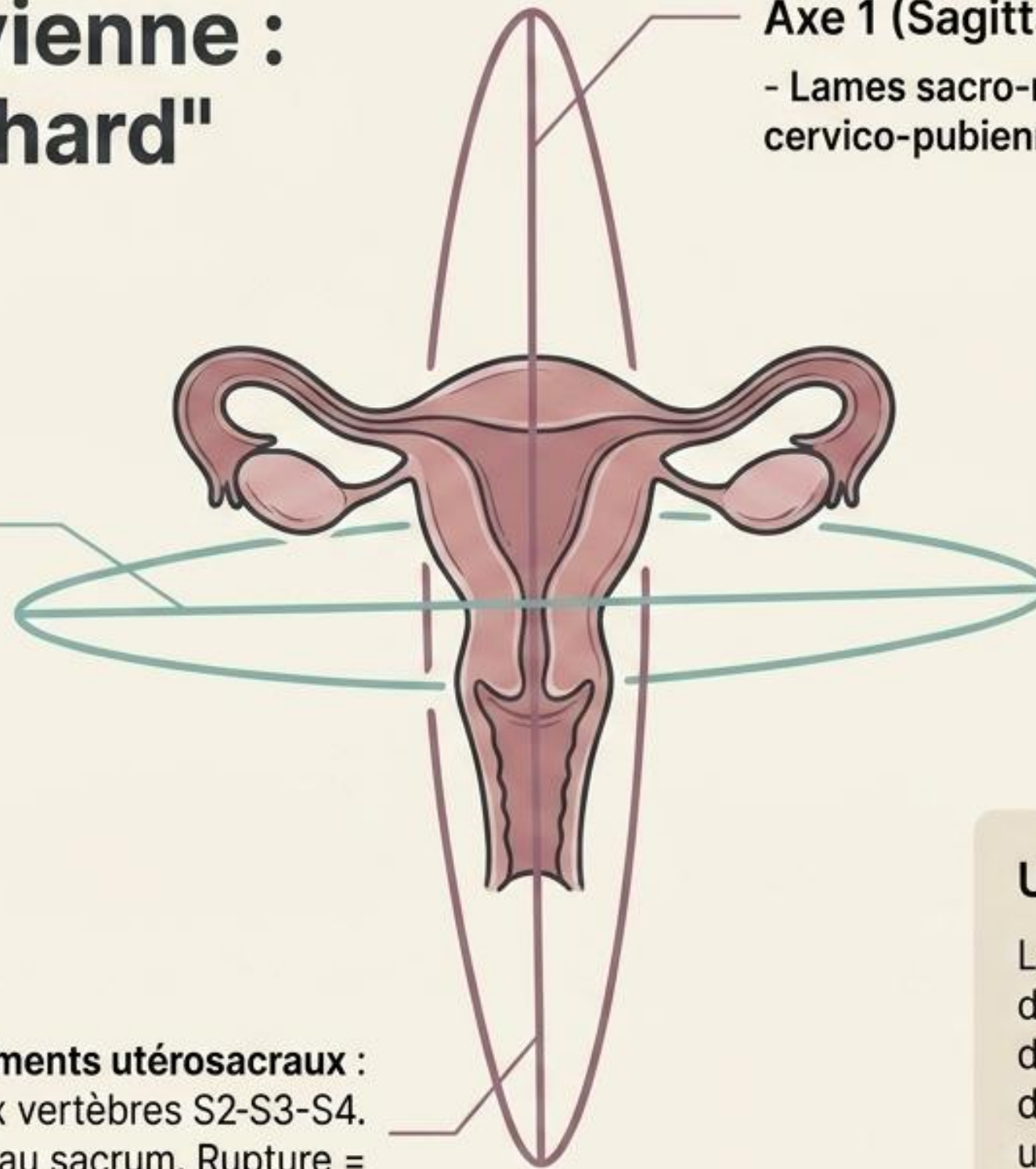
Axe 1 (Sagittal)

- Lames sacro-recto-génito-cervico-pubiennes (SRGCP)

Axe 2 (Transversal)

- **Ligaments larges** : Relient transversalement l'utérus à la paroi pelvienne interne.
Mésomètre (souple, supérieur) et **Paramètre** (épais, adhère au plancher).

- **Ligaments utérosacrals** : Relient l'isthme aux vertèbres S2-S3-S4. Fixent le col au sacrum. Rupture = principale cause de déviation du col.



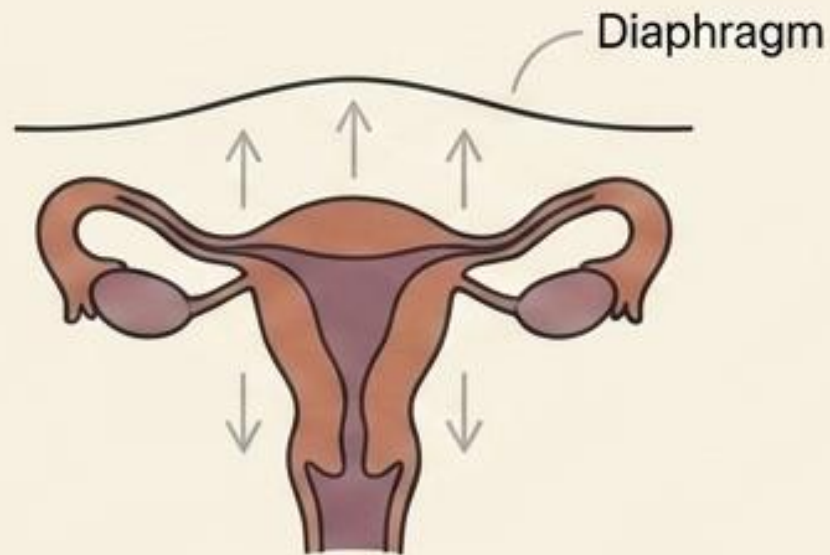
Une Fixation Intelligente

La région cervico-isthmique est l'axe de rotation. Les ligaments possèdent des fibres musculaires lisses au sein des fibres élastiques, leur conférant une contractilité active.

La Cinématique Pelvienne

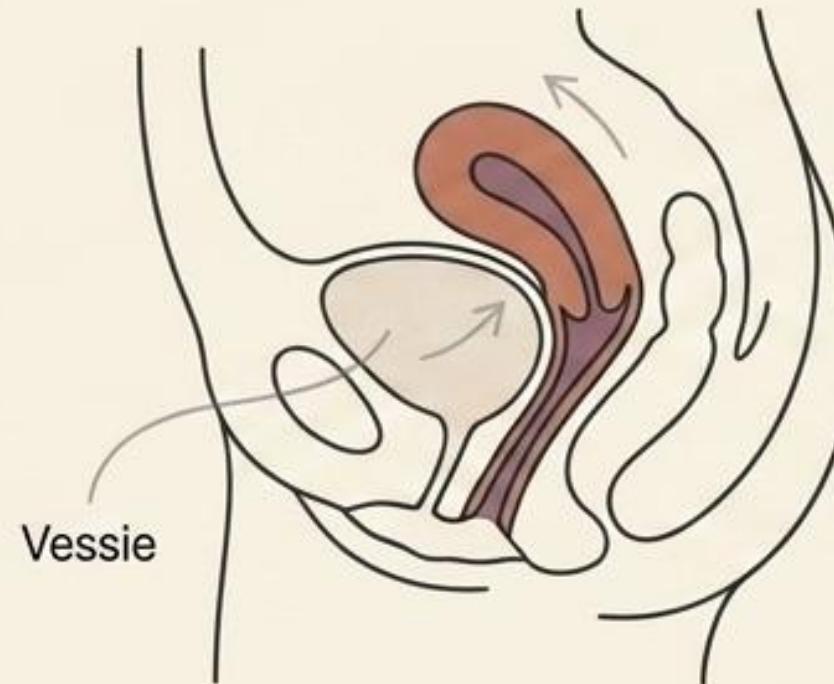
L'utérus n'est pas statique. Il doit rester mobile pour assurer ses fonctions.

2400 Mouvements/Jour



Le dôme utérin varie de 2cm lors de l'inspiration/expiration forcée. Une malposition utérine subissant ces mouvements sur un axe faussé crée une congestion locale.

Verticalisation



Lorsque la vessie se remplit, le corps utérin (posé sur elle) se verticalise et recule.

Poussée Ventrale



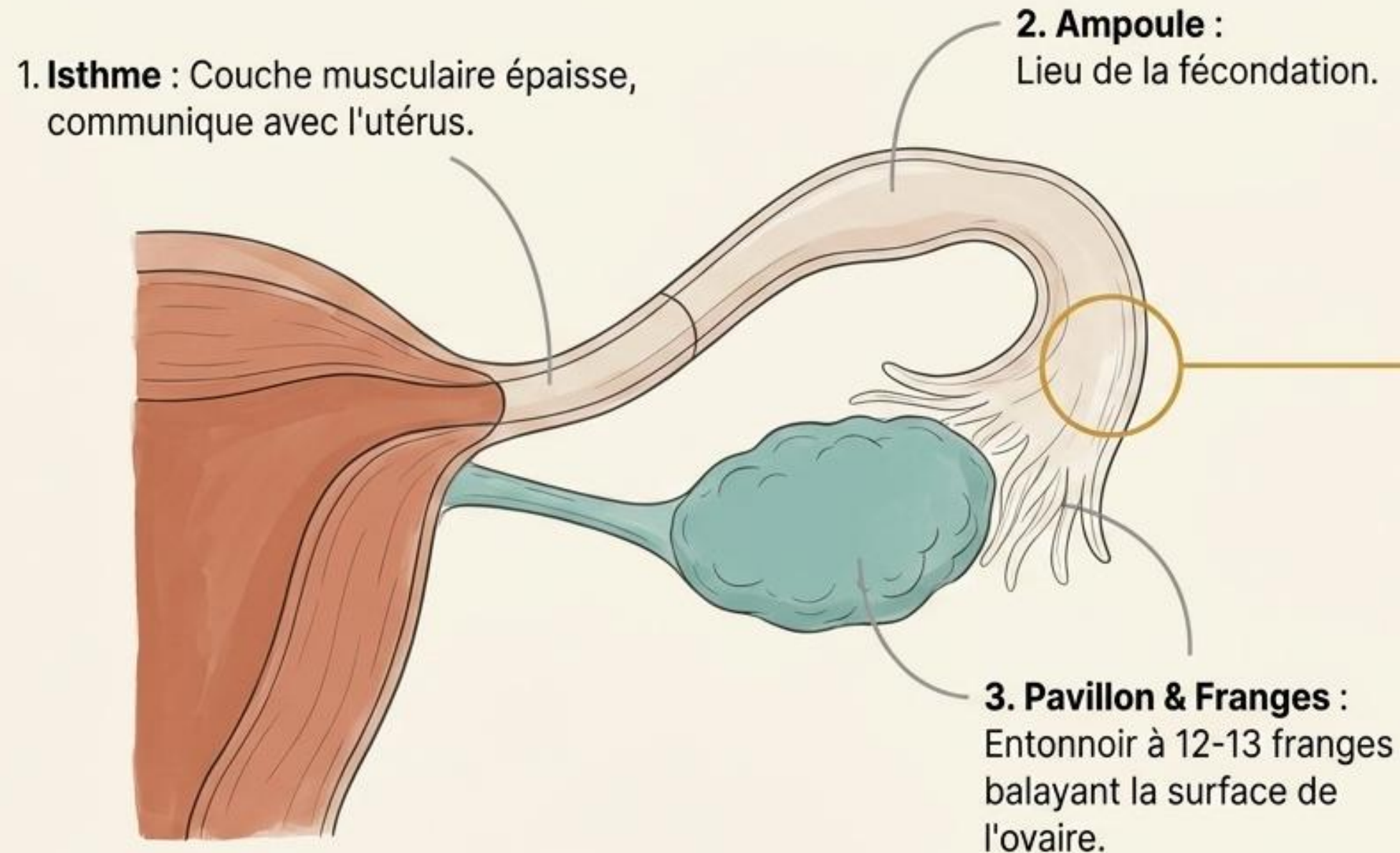
Une constipation basse opiniâtre chasse l'utérus ventralement.

Les mouvements actifs : Cycle hormonal (œstrogènes = myomètre lourd ; progestérone = hypotonie) et coït (orgasme = élévation rythmique de l'utérus).

Annexes : Trompes et Ovaire

La trompe (10-12cm) capte l'ovule et le guide vers l'utérus.

L'ovaire (glande génitale) est libre dans la cavité pelvienne, non péritonisé.

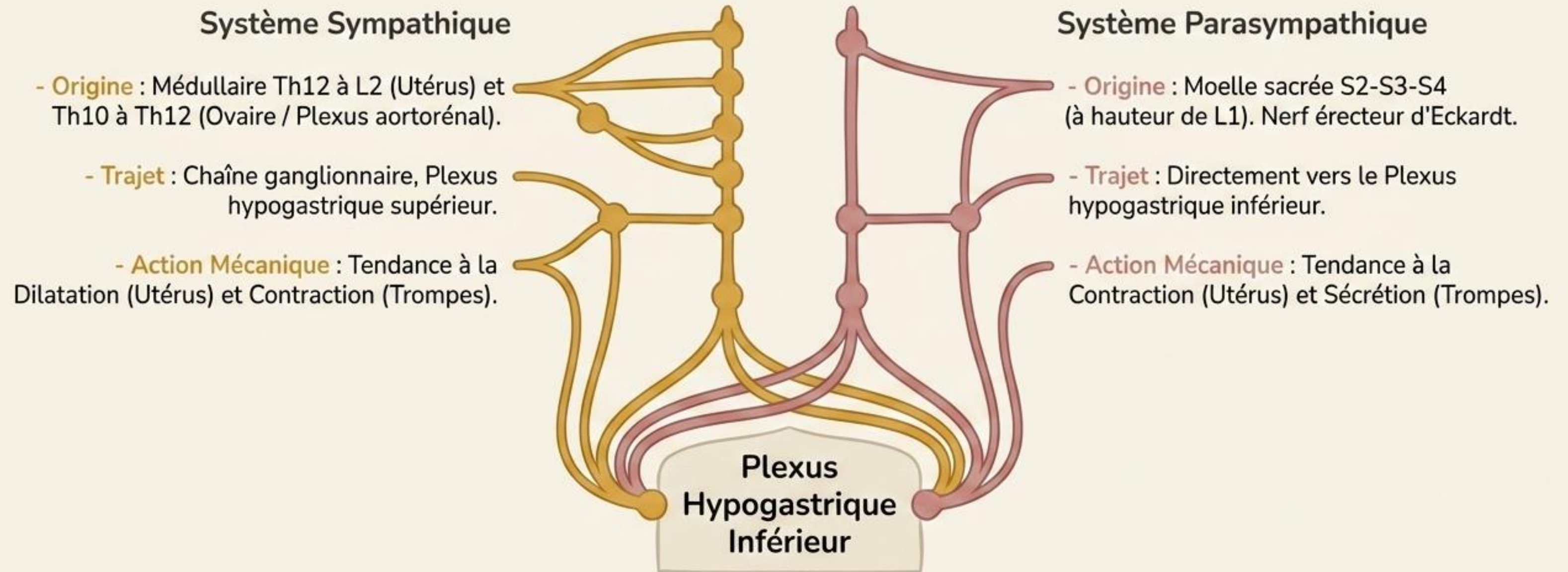


L'Ostium Abdominal : Cas unique dans l'organisme où une cavité muqueuse (trompe) communique avec une cavité séreuse (péritoine).

Conséquences :

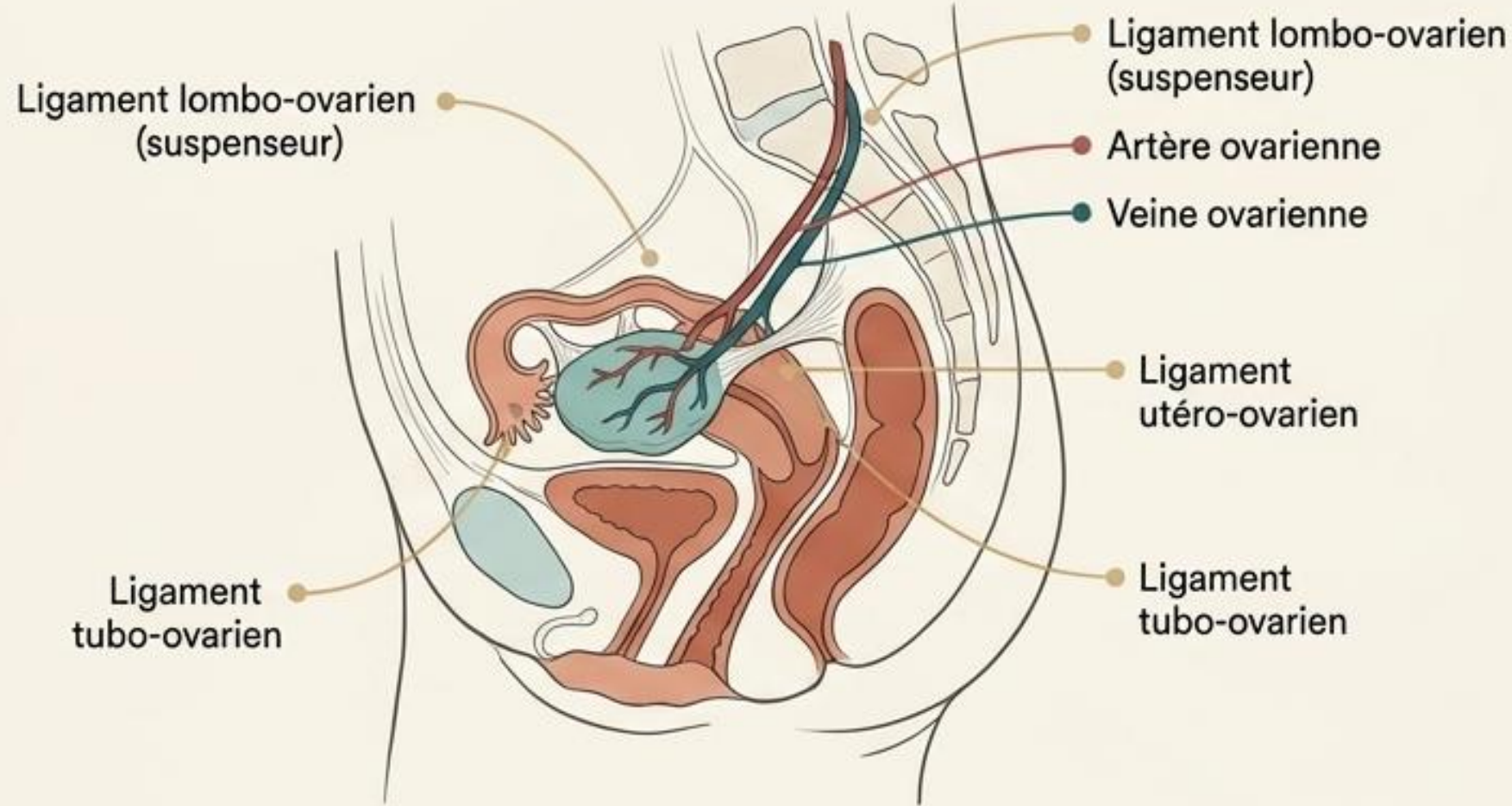
- Liquide tubaire mixte (péritonéal + muqueux).
- Risque de grossesse extra-utérine (GEU).
- Vulnérabilité aux adhérences post-opératoires (ex: appendicectomie).

Le Câblage Neuro-Végétatif Uro-Génital



Les ligaments utérosacrés sont gorgés de fibres sympathiques viscéro-sensibles.
Leur fibrose engendre des dysménorrhées intenses par déviation du col.

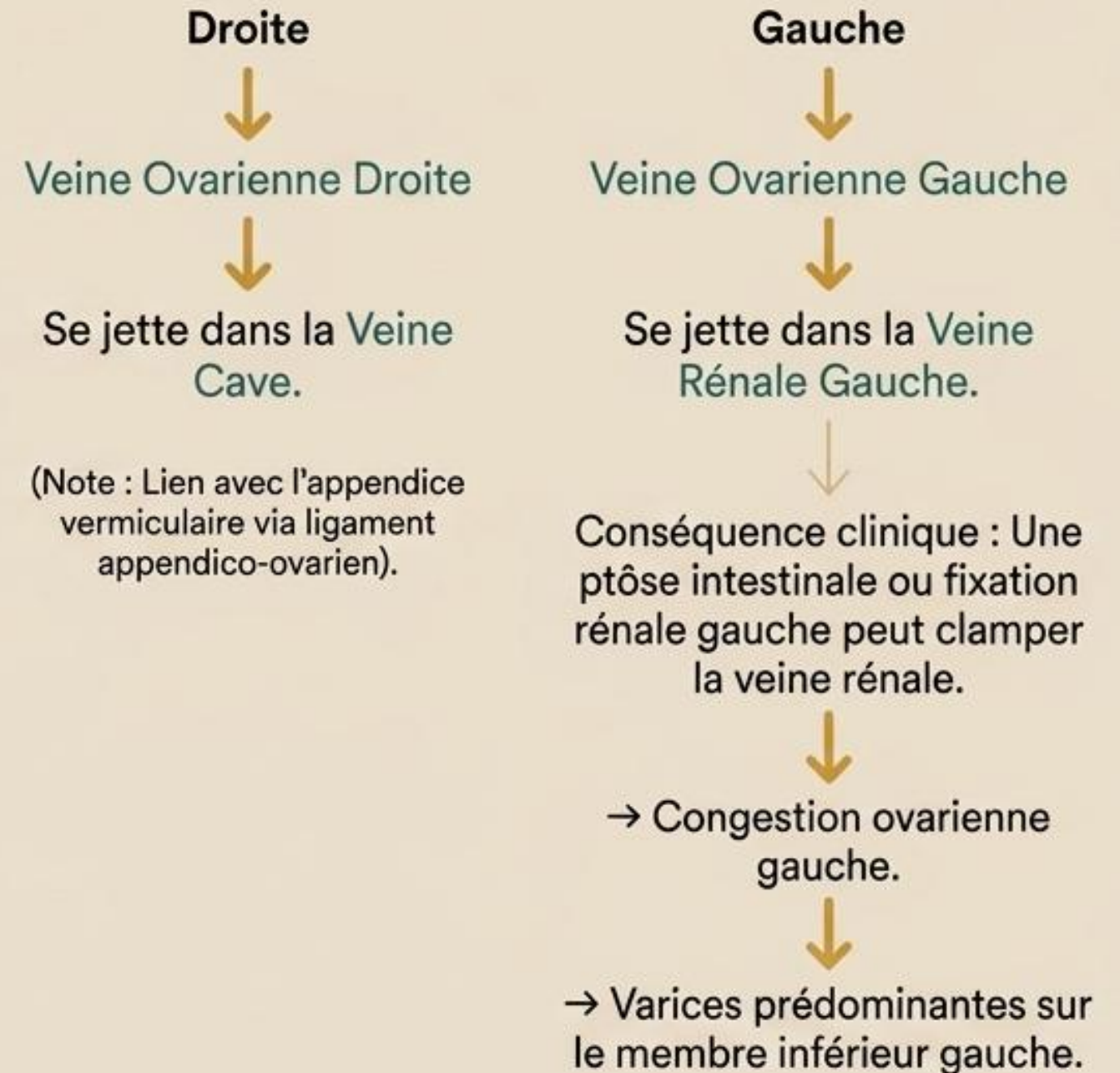
Fixation et Vascularisation Ovariennne



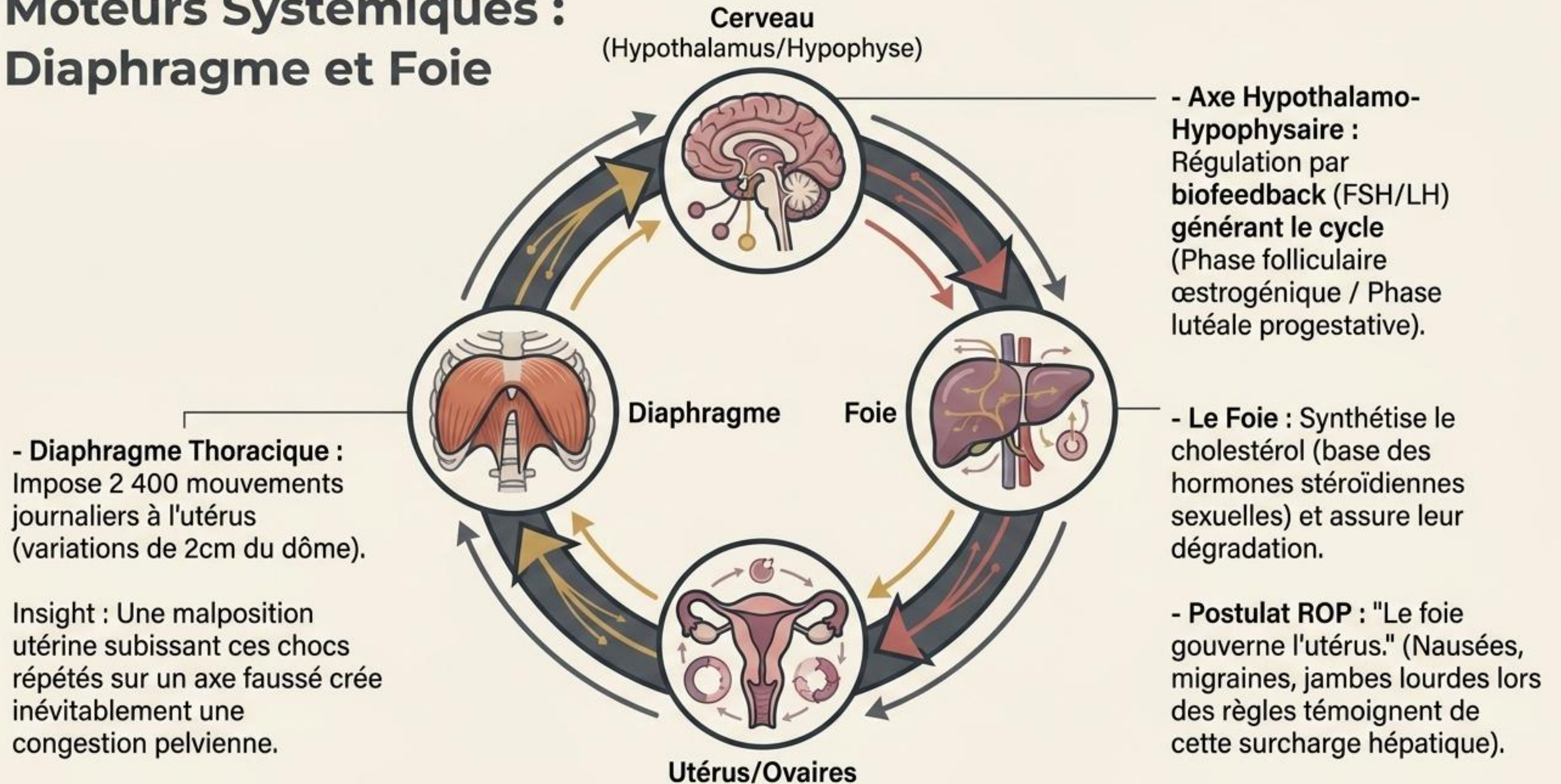
- **Ligament lombo-ovarien (suspenseur)** : Attache aux aponévroses lombaires. Porte-vaisseaux majeur.
- **Ligament utéro-ovarien** : Relie l'ovaire à la corne utérine.
- **Ligament tubo-ovarien** : Relie l'ovaire au pavillon.

Note : Ces ligaments agissent comme des "gonds" riches en fibres musculaires lisses, permettant la mobilité active de l'ovaire.

Drainage Veineux Ovarien (Intérêt ROP Majeur)



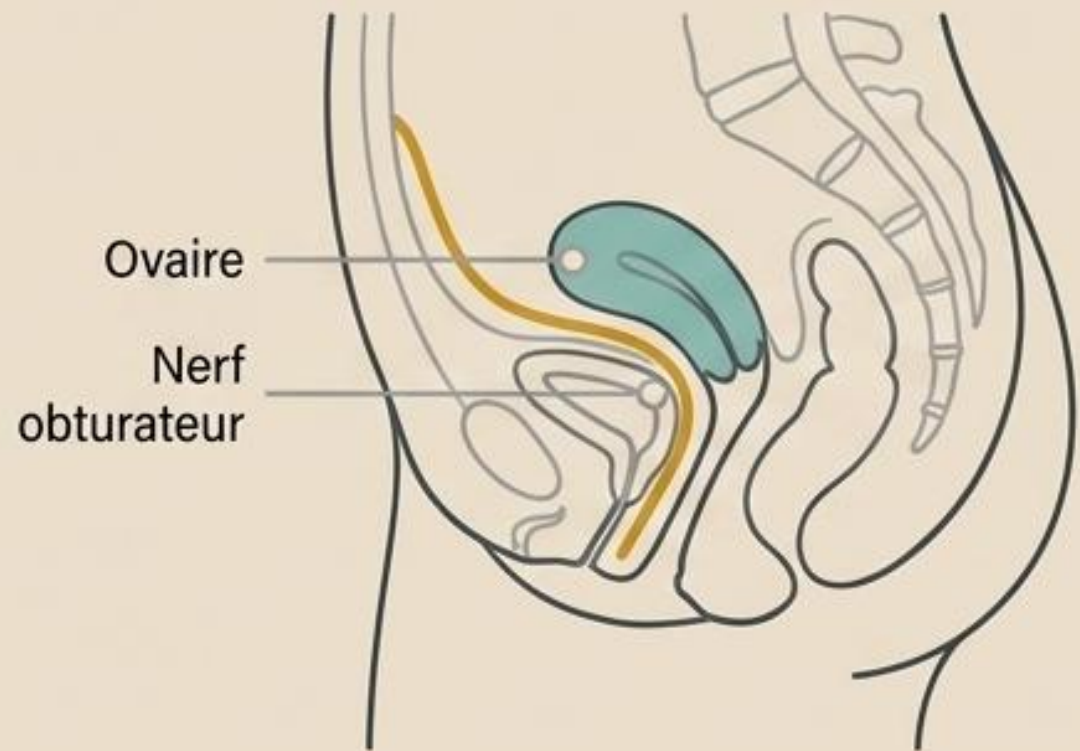
Moteurs Systémiques : Diaphragme et Foie



Topographie et Mobilité Ovariennne

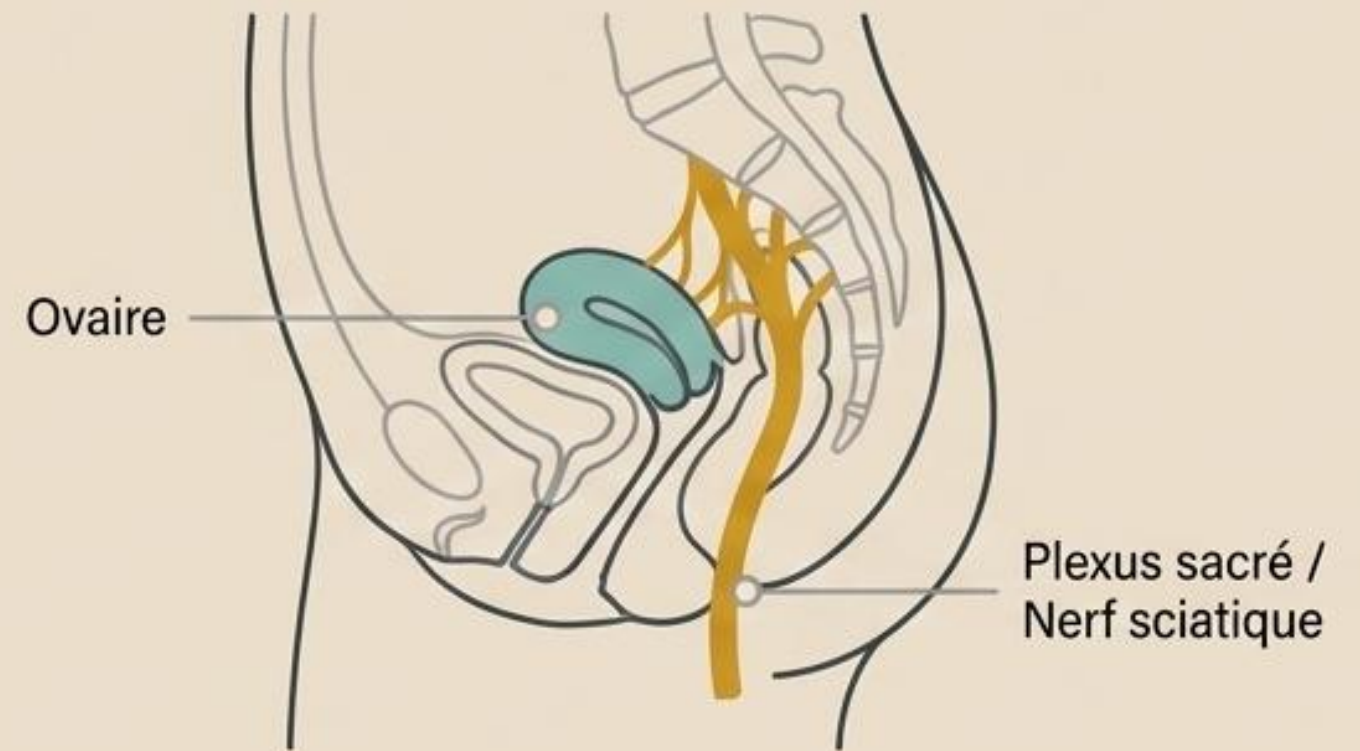
La position de l'ovaire évolue avec l'âge et les grossesses, modifiant les rapports neurologiques.

Jeune fille / Nullipare (La Fossette de Krause)



- Situation : Très haut, près du nerf obturateur.
- Expression clinique : En cas de congestion (ex: juste avant les règles), l'ovaire appuie sur le nerf.
- Conséquence : Gonalgies (douleurs du genou) de type congestif, non mécanique. Disparaît souvent avec la maturité hormonale.

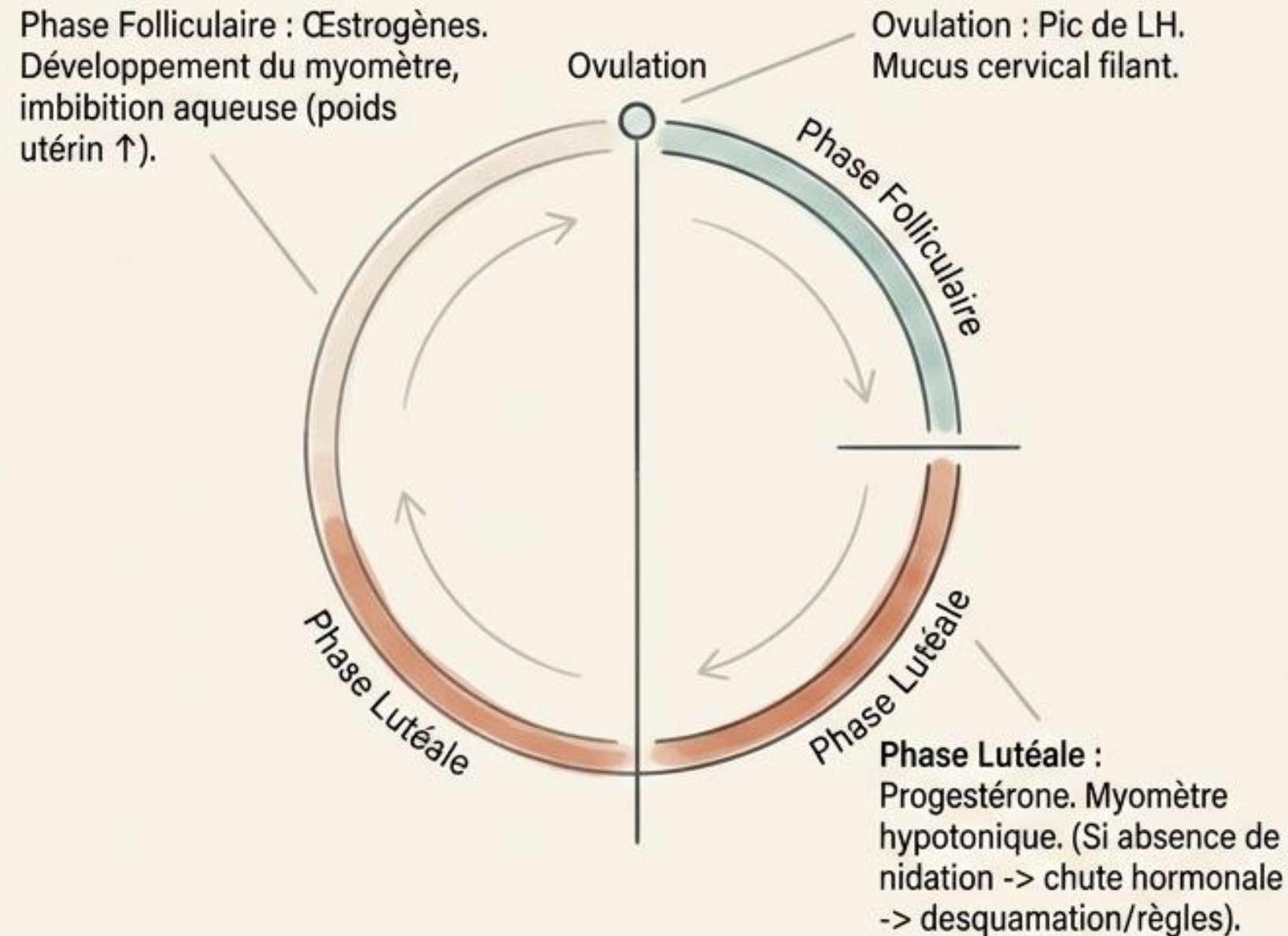
Multipare / Femme âgée (La Fossette de Claudius)



- Situation : Descend vers le cul-de-sac de Douglas, en contact avec le muscle piriforme.
- Expression clinique : Appui sur le plexus sacré.
- Conséquence : Lombo-sciatalgies à point de départ pelvien.

Le Cycle Hormonal et l'Axe Hépatique

La régulation hormonale dépend du biofeedback hypothalamo-hypophysaire, mais l'acteur métabolique central reste le foie.



1. Foie (Synthèse) :

Produit le cholestérol (précurseur des hormones stéroïdiennes).



2. Circulation : Hormones actives.



3. Foie (Dégradation) : Filtre et élimine les hormones par l'urine et la bile.



Pourquoi traiter le foie en ROP ?

Le foie gouverne le métabolisme génital. Un foie saturé élimine mal les hormones, accentuant le Syndrome Prémenstruel (SPM) : migraines, ballonnements, rétention hydrique, lourdeur des jambes.

Matrice Neuro-Végétative Pelvienne

Cartographie des origines médullaires et de leurs actions mécaniques.

Système	Origine Médullaire	Relais Plexique	Action Mécanique
UTÉRUS - SYMPATHIQUE	Th12 - L2	Plexus hypogastrique supérieur → inférieur	Tendance à la DILATATION (relâchement)
UTÉRUS - PARASYMPATHIQUE	S2 - S3 - S4 (Nerf érecteur d'Eckardt)	Plexus hypogastrique inférieur	Tendance à la CONTRACTION
OVAIRES & TROMPES - SYMPATHIQUE	Th10 - Th12	Plexus aortorénal (nerf petit splanchnique)	CONTRACTION (isthme tubaire)
OVAIRES & TROMPES - PARASYMPATHIQUE	S2 - S4 (Parasympathique pelvien)	-	SÉCRÉTION

Les ligaments utérosacrés sont densément fournis en fibres sympathiques viscéro-sensibles. Leur fibrose (par cicatrice ou malposition) irrite le plexus hypogastrique inférieur, générant de violentes dysménorrhées.

Evaluation de la douleur pelvienne

Douleurs Cycliques

Syndrome prémenstruel (SPM)

Dysménorrhée congestive (flux normal mais douloureux)

Dysménorrhée obstructive (retard du flux par malposition)

Douleurs Non-Cycliques

Fixations mécaniques (rétroversion par distension)

Dyspareunies (superficielle, de présence, profonde / Syndrome de Masters et Allen)

Urgences (Diagnostic d'exclusion)

Grossesse Extra-Utérine (GEU - douleur fosse iliaque, pertes sépia, retard de règles)

Hémorragies
Kystes organiques

Diagnostics d'Exclusion et Alertes Cliniques

Pathologies organiques nécessitant un avis médical immédiat. Contre-indications à la ROP génitale.

GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE (GEU)

- **URGENCE VITALE** (Risque d'hémorragie interne).
- Signes : Retard de règles (pertes "sépia"), douleur fosse iliaque, défense à la palpation.
- Piège : La première douleur peut être une lombalgie d'irradiation antérieure. Toujours demander la date des dernières règles.

HÉMORRAGIES & CANCERS

- **Métrorragies** : Hémorragies hors cycle. Toujours suspect, surtout post-ménopause.
- **Cancer du col** : Lié au HPV. Pertes, saignements, col induré.
- **Fibromes volumineux** : Risque de nécrobiose.

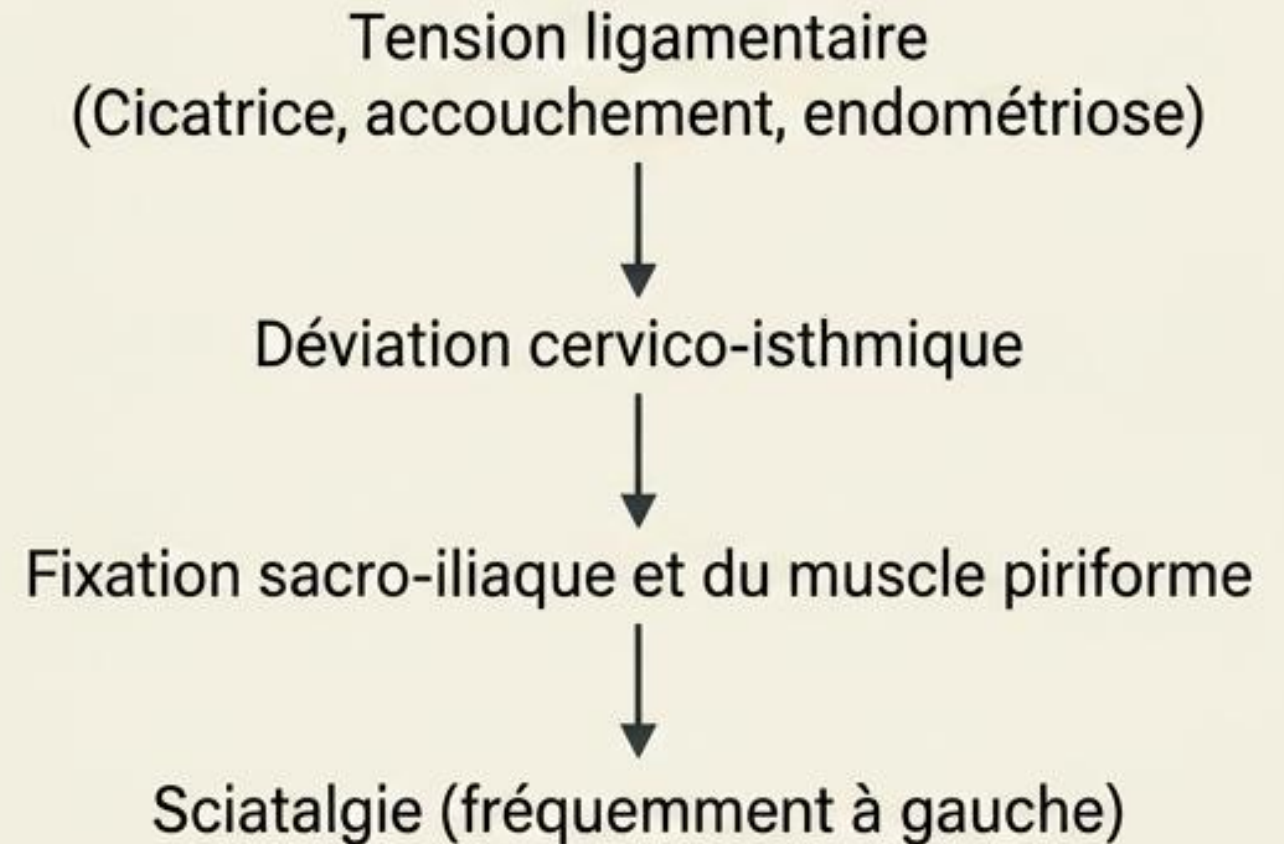
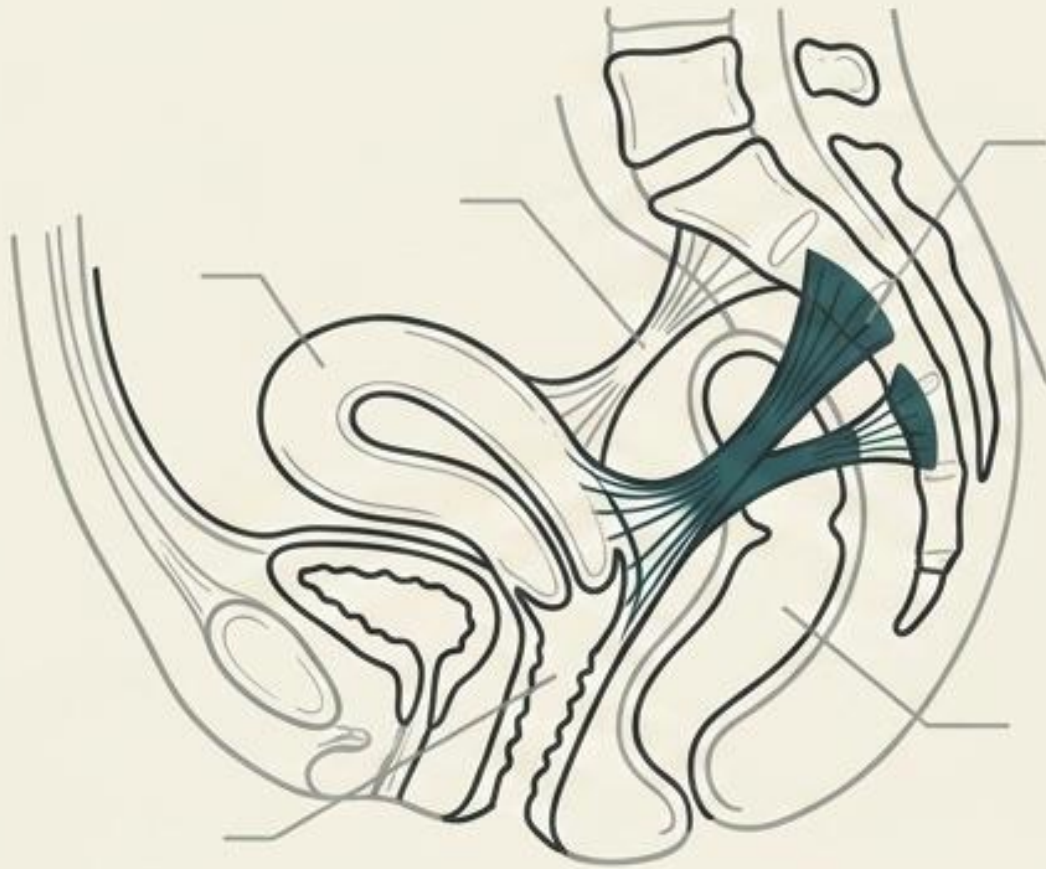
Kystes Organiques & Ovariens

- Signes : Pesanteur pelvienne, pollakiurie (envie d'uriner), altération de l'état général.
- Évolution silencieuse, diagnostic souvent tardif (ascite, œdèmes).

INFECTIONS (Salpingite)

- Infection des trompes (souvent chlamydia).
- Toujours bilatéral. Fièvre (37.5°C), leucorrhées malodorantes.
- Risque majeur de stérilité.

Pathologies fonctionnelles et chaînes lésionnelles



Endométriose et adhérences. La présence de tissu endométrial sur les ligaments utérosacrés s'accompagne d'importantes lombalgies. Les forces de traction désaxent l'articulation cervico-isthmique, répercutant le spasme sur le plexus sacré.

Cascades Pathologiques Mécaniques

Comment les lésions structurelles se propagent au système musculo-squelettique.

LA VOIE OSTÉO-ARTICULAIRE (De l'utérus à la sciatique)

1. Séquelle (Traumatisme obstétrical, chirurgie, infection)



2. Rétraction d'un ligament utérosacré



3. Déviation du col
(Axe cervico-isthmique faussé)



4. Fixation de l'articulation sacro-iliaque et du
muscle piriforme



5. Sciatalgie
(Très souvent à gauche en raison de la
prédominance de fixation du col à gauche).

LA VOIE LIGAMENTAIRE (Syndrome de Masters et Alben)

1. Rupture du releveur de l'anus ou ligament
utérosacré (accouchement difficile)



2. Perte du soutènement du col utérin



3. Coït : Le pénis butte sur un utérus fixé,
étirant le péritoine



4. Spasme abdominal, douleur fulgurante et
rémanente après les rapports.

Dimensions Viscéro-Émotionnelles

Le système uro-génital, richement innervé, est le premier récepteur des chocs affectifs.



La Personne "Génitale" (Utérus et Ovaires)

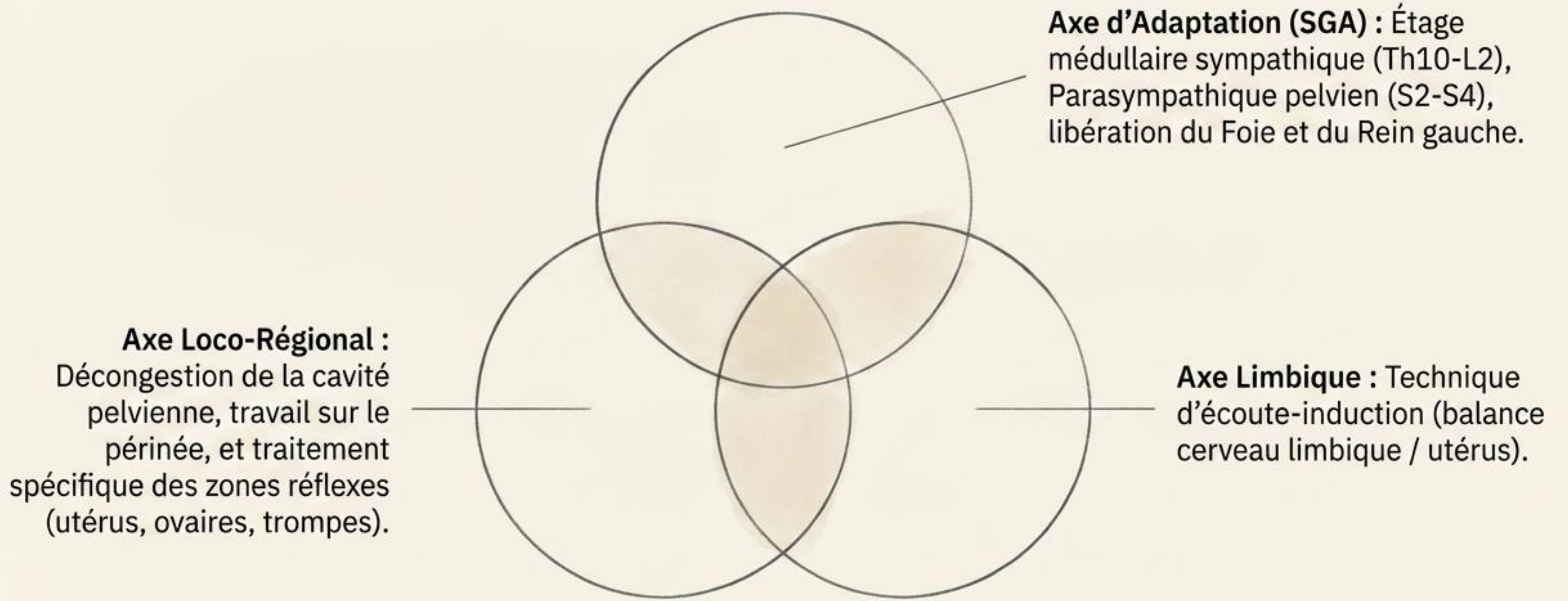
- **Symbole** : Fécondité, maternité, ancrage, sexualité.
- **Équilibre** : Besoin de donner, de recevoir et d'abriter.
- **Blessure** : Peur de l'abandon, difficulté à 'couper le cordon'.
- **Manifestation** : Chocs émotionnels ou violences sexuelles s'impriment dans le tissu (aménorrhées, infertilité fonctionnelle, dyspareunies). À la ménopause, sensation de perte de féminité.



La Personne "Sein"

- **Symbole** : Féminité, nutrition, point d'ancrage de la famille.
- **Équilibre** : Besoin de protéger, d'être protégée, recherche de la relation idéale.
- **Blessure** : Culpabilité, soumission pour éviter les heurts, sentiment d'échec face au départ des enfants.
- **Manifestation** : Développement de mastoses ou kystes mammaires suite à des bouleversements affectifs ou des trahisons redoutées.

Synthèse du protocole d'intégration ROP



Le praticien ROP ne traite pas qu'une structure mécanique ; il harmonise un carrefour vasculaire, viscéral et émotionnel sous haute dépendance neuro-végétative.